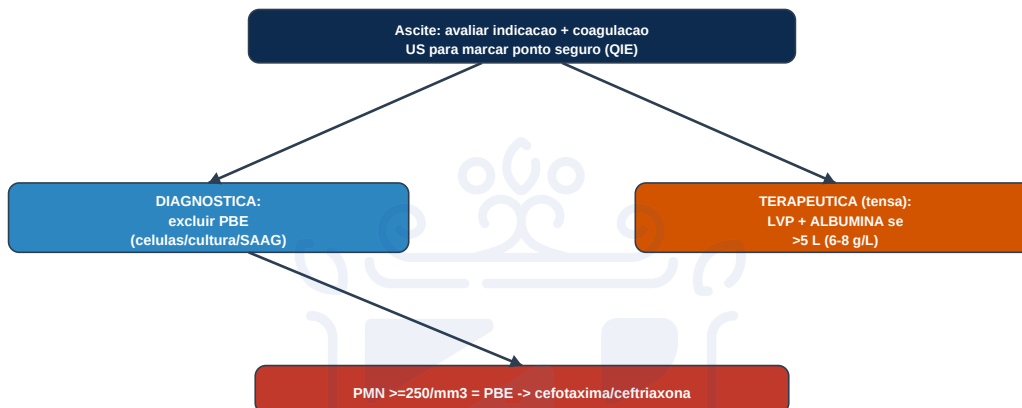


PARACENTESE — PBE + SAAG + ALBUMINA

FLUXOGRAMA — DIAGNÓSTICA x TERAPÊUTICA

PARACENTESE — PUNÇONAR -> ANALISAR / ALIVIAR



INDICAÇÕES

Tipo	Situações
Diagnóstica	Ascite nova; cirrótico internado (excluir PBE); sinais de infecção/deterioração: febre, dor abdominal, confusão (encefalopatia), leucocitose, IRA
Terapêutica	Ascite TENSA/sintomática (dispneia, desconforto); alívio imediato de pressão; ascite refratária a diuréticos

CONTRAINDICAÇÕES

Tipo	Observação
Absolutas	CIVD ativa/coagulopatia grave não reversível; infecção de pele no local de punção
Relativas	Distensão intestinal intensa, aderências extensas, gestação avançada
Coagulopatia leve / plaquetas > 50.000	Geralmente SEGURA com cuidado — coagulopatia isolada NÃO contraindica se há indicação urgente

PRÉ-PROCEDIMENTO E MATERIAL

PREPARO

- Avaliação: história/exame, sinais vitais e estabilidade; labs (hemograma, plaquetas, INR/TTPa, função renal)
- US abdominal preferencial: confirma líquido, identifica o melhor ponto e evita vasos/órgãos/aderências
- Material: luvas estéreis, campo, antisséptico (clorexidina 2%), agulha/cateter 14-18G com seringa 20 mL, conjunto de drenagem/bolsa (LVP), lidocaína 1-2%, frascos de hemocultura e tubos para citologia/bioquímica
- Drogas: Lidocaína 1-2% sem vaso 5-10 mL; Albumina 20-25% 6-8 g por litro retirado se LVP > 5 L; Dipirona 1 g para conforto; sedação leve (Midazolam 0,02-0,05 mg/kg) só se ansioso e monitorizado
- ATB se PBE suspeita/confirmada: Cefotaxima 2 g EV 8/8h ou Ceftriaxona 1 g EV/dia

T CNICA PASSO A PASSO

Rx Z-TRACK NO QIE

Local: quadrante inferior ESQUERDO, 5-8 cm acima da s nfise p blica e lateral   linha m dia (ou QID se melhor)
EVITAR a linha m dia (risco de les o de bexiga) e a regi o subcostal (f gado/ba o); confirmar l quido por US/palpa o e marcar
Posi o: dec bito dorsal, tronco levemente elevado, joelhos semifletidos; antisepsia + anestesia com lidoca na (pele -> perit nio)
T cnica Z-TRACK: deslocar a pele lateralmente antes de inserir a agulha (reduz vazamento posterior de l quido)
Inserir perpendicularmente aspirando; ao atingir o perit nio, coletar amostras e/ou conectar dreno para LVP; monitorar sinais vitais
LVP: remover lentamente (1-4h conforme volume); repor ALBUMINA 20-25% IV (6-8 g/L) ap s retirar > 5 L

AN LISE DO L QUIDO ASC TICO

Exame	Interpreta�o
C�lulas + diferencial	≥ 250 NEUTR�FILOS/mm ³ sugere PBE
Cultura (frasco de hemocultura)	Maior sensibilidade na identifica�o do agente
SAAG (gradiente albumina soro-ascite)	$\geq 1,1$ = hipertens�o portal (transudato); $< 1,1$ = outras causas
Prote�nas, glicose, citologia, amilase	Conforme suspeita (neoplasia, pancre�tica, etc.)

P S-PROCEDIMENTO E COMPLICA  ES

CUIDADOS

- ☐ Cobrir o s tio com curativo est ril; monitorar sinais vitais e diurese
- ☐ Observar hipotens o p s-paracentese (prevenir com albumina na LVP), sangramento e perfura o
- ☐ Reavaliar necessidade de repetir a paracentese ou ajustar a terap utica (diur tico, restri o de s dio)
- ☐ Complica  es: hipotens o p s-paracentese (disfun o circulat ria), sangramento local, perfura o intestinal (rara), infec o do s tio, vazamento de l quido
- ☐ PBE confirmada (PMN ≥ 250): iniciar ATB e considerar albumina (reduz s ndrome hepatorenal); profilaxia secund ria ap s o epis dio

MODELO DE REGULA  O / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULA  O

- Paciente ____ anos com ascite (cirrose/neoplasia/IC); indica o: diagn stica (excluir PBE) / terap utica (tensa).
- Coagula o: plaquetas ____, INR ____; US marcou ponto no QIE ____; volume retirado ____ L; albumina ____ g (se > 5 L).
- L quido: PMN ____ /mm³ (PBE?), cultura ____, SAAG ____; ATB ____ (se PBE).
- Solicito intern o/seguimento (PBE -> ATB + albumina); vigiar hipotens o p s-paracentese e fun o renal.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual contagem no líquido ascítico define peritonite bacteriana espontânea (PBE)?

- A) ≥ 250 neutrófilos/mm³
- B) > 50 hemácias/mm³
- C) Glicose < 100
- D) Proteína > 3 g/dL
- E) Qualquer leucócito

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Após paracentese de grande volume (> 5 L), o que deve ser administrado para prevenir a disfunção circulatória/hipotensão?

- A) Solução glicosada
- B) Albumina 20-25% IV (6-8 g por litro retirado)
- C) Antibiótico
- D) Diurético em bolus
- E) Plasma fresco para todos

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o local preferencial de punção na paracentese?

- A) Linha média infraumbilical
- B) Quadrante inferior esquerdo (lateral à linha média, acima da sínfise)
- C) Região subcostal direita
- D) Epigástrico
- E) Hipocôndrio esquerdo

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Um SAAG (gradiente albumina soro-ascite) $\geq 1,1$ g/dL indica:

- A) Ascite por hipertensão portal
- B) Ascite neoplásica
- C) Tuberculose peritoneal
- D) Pancreatite
- E) Síndrome nefrótica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre coagulopatia e paracentese, é correto:

- A) Qualquer alteração da coagulação contraindica o procedimento
- B) Coagulopatia leve isolada (plaquetas > 50.000) geralmente não contraindica a paracentese quando há indicação
- C) Sempre transfundir plasma antes
- D) Nunca puncionar cirróticos
- E) Exige INR $< 1,0$

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

Contagem ≥ 250 neutrófilos/mm³ no líquido ascítico define PBE, indicando antibiótico (cefotaxima/ceftriaxona) e, em geral, albumina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Após LVP > 5 L, repõe-se albumina 20-25% IV (6-8 g por litro retirado) para prevenir a disfunção circulatória pós-paracentese e a hipotensão.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O local preferencial é o quadrante inferior esquerdo, lateral à linha média e acima da sínfise púbica, evitando linha média (bexiga) e região subcostal (fígado/baço).

QUESTÃO 4 → Resposta: A

SAAG $\geq 1,1$ g/dL indica ascite por hipertensão portal (transudativa, como na cirrose); $< 1,1$ sugere outras causas (neoplasia, TB, pancreática).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Coagulopatia leve isolada (incluindo plaquetas > 50.000) geralmente não contraindica a paracentese quando há indicação; coagulopatia isolada não é, por si, contraindicação absoluta.

SM24
Suporte ao Plantão Médico